

経鼻経管栄養における安全なチューブ挿入と、注入可能な要件

使用する栄養チューブ

JMS E/Dチューブ 10Fr 120cm

X線不透過ライン全面にあり、基本的に、チューブが詰らない限り交換不要

先端は非金属なので、挿入したままでのMRI撮影は可能

チューブが正しく挿入されているかは、以下の方法で確認する

(1) 20cmチューブ挿入時に確認すること

- ①口腔内及び咽頭でチューブが迷走していないか
- ②咽頭で正中線と交差していないか
- ③気管に入っていないか

チューブの端から呼吸音が聞こえてこないか、呼気が漏れてこないか、挿入時に咳嗽反射がないか確認する

(2) チューブが胃内留置されたかの確認方法

①気泡音の確認:

聴診で確認する場合は、注射器を何度も押してその動きに連動した音であるか確認する(他人に注射器を押してもらって聴くという行為は禁忌) 聴診器を両肺野と心窩部の3か所にあて、それぞれの部位で空気を注入(各10~20ml)し、気泡音(ゴホッ)が聴こえるか? 最強音が心窩部であるかを確認する

②内容物を吸引する

③制酸薬の投薬がない場合は、吸引した内容物のpH測定を行ない、pH5.5以下なら胃液と判断する

④X線での確認(照射録には「胸部単純 栄養チューブ位置確認」と記入)

*** 注入可能な要件: (1) の①②③すべてがOK**

上記の確認事項の

すべてを実施した上で

(2) の①~③のうち1つ以上がOK

(2) の④がOK

* (1)(2)の確認の結果は、テンプレート「経鼻栄養チューブ挿入記録」に記載をする

* チューブの挿入は、必ず日勤で行う。早朝や夜勤帯では、胃内挿入のレントゲン確認ができないので行わない

* 初回注入は、急変に備え、必ず日勤で行う (医師がすぐ来ることができる時間)

* 数cm抜けているチューブを発見した時は、専用の記録用紙を使用して、その時点でチューブが胃内に入っているかどうかの確認を行う
明らかに、胃内に入っていないと判断できるほど、チューブが抜けている場合は、そのまま引き抜き、手順に従って再挿入する